

■ DATOS SINTÉTICOS - SOLO PARA PRUEBAS - NO ES PACIENTE REAL ■

Este documento fue generado automáticamente para el desarrollo del clinical-extractor de SICA. No contiene PHI ni representa una paciente real. Cualquier semejanza con un caso clínico real es coincidencia.

HISTORIA CLÍNICA OBSTÉTRICA

Centro Materno-Infantil (sintético) — Hospitalización Obstétrica

FILIACIÓN

Nombre:	PACIENTE SINTÉTICA - NO REAL
Edad:	35 años
Estado civil:	Casada
Ocupación:	Docente
Fecha de elaboración:	10/05/2026

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

Fórmula obstétrica: G3 P2 (2 partos vaginales previos, 2018 y 2021, sin complicaciones).

Niega antecedentes de hipertensión crónica, diabetes ni nefropatía. Sin antecedentes familiares de preeclampsia.

GESTACIÓN ACTUAL

FUM:	01/10/2025
FPP:	08/07/2026
EG actual (por FUM):	32 semanas
Controles prenatales:	7 al momento
Motivo de ingreso:	Hipertensión gestacional severa con proteinuria

Paciente refiere cefalea persistente y edema progresivo en miembros inferiores en últimas 48 h. Niega epigastralgia, visión borrosa o tinnitus. Movimientos fetales presentes y normales.

EXAMEN FÍSICO ACTUAL

PA 158/102 mmHg (confirmada en dos tomas separadas por 4 h). FC 88 lpm. T° 36.6°C. Peso 78.2 kg. Edema MMII (++) hasta tercio medio de pierna. Reflejos osteotendinosos normales. AU 30 cm. LCF 144 lpm.

LABORATORIOS (10/05/2026)

Analito	Resultado	Unidad	Observación
Hemoglobina	11.8	g/dL	Dentro de rango
Plaquetas	95000	/mm³	Plaquetopenia
Creatinina	0.9	mg/dL	Normal
AST (TGO)	38	U/L	Discreto incremento
ALT (TGP)	42	U/L	Discreto incremento
LDH	320	U/L	Normal-alto
Proteinuria tira	2+	—	Cualitativa positiva
Proteinuria 24 h	1.8	g/24 h	Significativa

PLAN

1. Hospitalización en sala obstétrica de alto riesgo. 2. Inicio de sulfato de magnesio según protocolo (dosis de carga 4 g EV en 20 min, mantenimiento 1 g/h). 3. Maduración pulmonar fetal con betametasona 12 mg IM c/24 h x 2 dosis. 4. Antihipertensivos según meta de PA <150/100. 5. Monitoreo materno (PA c/15 min, diuresis horaria) y fetal (NST diario). 6. Reevaluación obstétrica para definir momento y vía de parto.